

Guía clínica de urgencias — actualización 2025

Dr. Ignacio Salcedo Pinar

Guía clínica de urgencias — actualización 2025

Vigencia: desde el 20 de febrero de 2025. Aplica a: todo el personal sanitario asignado al servicio de urgencias de Clínica Delos. Sustituye íntegramente el protocolo de marzo de 2023.

1. Objeto

Esta guía actualiza los criterios de triaje, tiempos de atención y procedimientos del servicio de urgencias, incorporando las lecciones aprendidas de los dos años de aplicación del protocolo anterior y las recomendaciones de la última auditoría de calidad asistencial (noviembre 2024).

2. Sistema de triaje actualizado

El servicio adopta un sistema de triaje de 5 niveles, alineado con el Sistema Español de Triage (SET), para una mayor granularidad en la clasificación de pacientes:

- **Nivel 1 — Resucitación:** riesgo vital inmediato. Atención instantánea. Ejemplos: parada cardiorrespiratoria, politraumatismo con inestabilidad hemodinámica, anafilaxia severa.
- **Nivel 2 — Emergencia:** situación de alto riesgo. Atención en un plazo máximo de **10 minutos**. Ejemplos: dolor torácico con sospecha de SCA, ictus con menos de 4.5 horas de evolución, estatus epiléptico.
- **Nivel 3 — Urgencia:** situación que requiere atención prioritaria. Tiempo máximo de espera: **30 minutos**. Ejemplos: dolor abdominal agudo, disnea moderada, crisis hipertensiva sin daño orgánico.
- **Nivel 4 — Menos urgente:** situación de baja complejidad que precisa evaluación médica. Tiempo máximo de espera: **60 minutos**. Ejemplos: esguinces, heridas que requieren sutura, fiebre persistente sin focalidad.
- **Nivel 5 — No urgente:** situación que podría resolverse en atención primaria. Tiempo máximo de espera: **120 minutos**. Ejemplos: resfriados, renovación de recetas, certificados médicos.

La reevaluación del nivel de triaje se realizará cada 30 minutos para los niveles 3 y 4, y cada 60 minutos para el nivel 5.

3. Dotación de personal reforzada

Tras el análisis de carga asistencial realizado en 2024, se refuerza la dotación mínima por turno:

- **Turno de mañana (8:00–15:00):** 3 médicos, 4 enfermeros/as, 2 auxiliares, 1 celador.
- **Turno de tarde (15:00–22:00):** 2 médicos, 3 enfermeros/as, 1 auxiliar, 1 celador.
- **Turno de noche (22:00–8:00):** 2 médicos, 2 enfermeros/as, 1 auxiliar, 1 celador.

Se incorpora un enfermero de triaje dedicado en los turnos de mañana y tarde, liberando al personal asistencial de esta función.

4. Circuito del paciente optimizado

1. **Pre-registro digital:** los pacientes con cita previa o derivación de atención primaria pueden completar el registro desde la app del centro antes de su llegada.
2. **Triaje:** evaluación por enfermería en los **5 primeros minutos** desde el registro (antes 10 minutos).
3. **Asignación de box:** el sistema informático asigna automáticamente el box disponible según nivel de triaje y especialidad requerida.
4. **Valoración médica:** anamnesis, exploración y solicitud de pruebas. Se establece un tiempo objetivo de primera valoración médica tras el triaje:
 - Nivel 2: 10 minutos
 - Nivel 3: 30 minutos
 - Nivel 4: 60 minutos
5. **Pruebas complementarias:** integradas con el sistema PACS y el laboratorio central mediante petición electrónica. Los resultados se publican directamente en la historia clínica.
6. **Diagnóstico, tratamiento y destino:** el médico documenta el plan terapéutico y la decisión de alta, ingreso o derivación.

5. Tiempos máximos de respuesta actualizados

Prueba	Tiempo máximo	Cambio respecto a 2023
Analítica urgente	45 minutos	Mejora: era 60 min
Radiografía simple	20 minutos	Mejora: era 30 min
ECG	5 minutos	Mejora: era 10 min
TAC urgente	30 minutos	Mejora: era 45 min
Ecografía point-of-care	15 minutos	Nuevo

6. Protocolo de código tiempo-dependiente

Se establecen vías clínicas rápidas para las patologías tiempo-dependientes:

- **Código infarto:** activación del laboratorio de hemodinámica con objetivo puerta-balón inferior a 90 minutos.
- **Código ictus:** activación de neurología de guardia con objetivo puerta-TAC inferior a 20 minutos y puerta-aguja inferior a 60 minutos.
- **Código sepsis:** inicio de resucitación hemodinámica y antibioterapia empírica en los primeros 60 minutos desde la sospecha clínica.

7. Indicadores de calidad

El servicio monitoriza mensualmente los siguientes indicadores:

- Tiempo medio de triaje.
- Tiempo medio de primera valoración médica.
- Porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos de espera.
- Tasa de reingresos a las 72 horas.
- Satisfacción del paciente (encuesta post-alta).

Los resultados se presentan en la sesión clínica mensual del servicio y se remiten a la dirección médica.

8. Formación y simulacros

Todo el personal del servicio de urgencias debe completar al menos 2 simulacros anuales de activación de códigos tiempo-dependientes y 1 simulacro de catástrofes. La formación en soporte vital avanzado se renueva cada 2 años.

Firmado: Dr. Ignacio Salcedo Pinar · Jefe de servicio de urgencias · Clínica Delos · 20 de febrero de 2025.